CNAM — TITRE RNCP PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL (NIVEAU 7)

PST123 · Séance 4 : Les Spécificités de l'Accompagnement en Milieu de Travail

Posture clinique, déplacement de la demande, niveaux de prévention et déontologie en milieu organisationnel

Enseignante : Dr. Prisca LUTUMBA (Psychologue clinicienne du travail)

Date du cours : Samedi 7 Novembre 2026 (09h00 – 12h00) **Format :** Regroupement Présentiel (Salle 2 - Sadi Carnot)

Durée audio analysée : 2 h 01 min (intégrale)

---

1. Fiche Synthétique « L'Essentiel du Cours »

🎯 **FIL CONDUCTEUR FONDAMENTAL**

« Déplacer la demande individuelle vers l'analyse du travail réel : de l'écoute compassionnelle à l'intervention clinique déontologique. » L'intervention du psychologue du travail en entreprise ne consiste jamais à soigner des individus défaillants au chevet du patronat, mais à faire émerger le *tiers-travail*, à transformer les représentations de la gouvernance et à rétablir le pouvoir d'agir des collectifs professionnels.

🧠 CE QU'IL FAUT SAVOIR (THÉORIE & CLINIQUE)

- **Le déplacement de la demande :** Face à une direction exigeant une « cellule d'écoute » pour des arrêts maladie, le clinicien refuse de cibler l'individu ou de violer le secret médical (l'employeur n'a pas accès aux motifs). Il déplace l'objet vers l'organisation, les arbitrages de métier et l'écart entre prescrit et réel.
- **PTO vs Cliniques du Travail :** La PTO anglo-saxonne use d'une approche hypothético-déductive et quantitative par questionnaires. Le Cnam revendique une démarche *inductive et qualitative* fondée sur le travail réel et l'écoute du vécu des opérateurs.
- **La santé comme pouvoir d'agir :** La santé n'est pas l'absence de symptômes mais la capacité d'agir, de créer et de transformer son milieu (héritage de Canguilhem, Saint-Alban, Le Guillant, Clot et Dejours).
- **Le travail comme tiers médiateur :** Le travail agit comme objet transitionnel qui protège du face-à-face imaginaire narcissique entre manager et collaborateur, et permet de dialectiser la résonance symbolique personnelle.

🎓 CE QU'IL FAUT RETENIR (COPIE D'EXAMEN CNAM)

- **« Analyser la demande, c'est déjà transformer » :** Contrairement à un audit technique validant un cahier des charges, l'analyse clinique de la demande questionne le commanditaire et amorce la transformation des représentations.
- **Matrice des 4 dispositifs collectifs :** Distinguer strictement Régulation d'équipe (conflits, ligne hiérarchique possible), APP (pairs stricts sans hiérarchie), Intervision (pairs sans superviseur) et Supervision (analyse de la posture avec tiers expert).
- **Règle d'or de restitution :** Proscrire formellement tout verbatim individuel dans les rapports en entreprise pour protéger les salariés contre les représailles de pairs ou du management.
- **Déontologie & Statut RPPS :** Professionnels de santé mentale autonomes issus des sciences humaines (Loi 1985). Aucune subordination à la prescription médicale. Principe premier : respect inaliénable de la personne physique et psychique.

⚠️ **Le Piège d'Examen Impardonnable selon le Dr. Prisca Lutumba :** Confondre le rôle de psychologue du travail avec un psychothérapeute individuel qui viendrait faire de la compassion en cabinet d'entreprise sans interroger le travail réel ; qualifier un comportement de « harcèlement moral » (qualification juridique réservée exclusivement au juge, exposant les médecins à des poursuites ordinales) ; ou insérer des citations nominatives/verbatims identifiables dans une restitution de rapport institutionnel.

2. Étude de Cas Clinique Introductive : La Demande de « Cellule d'Écoute »

Le cours débute par une mise en situation clinique concrète, immédiatement contextualisée par rapport aux exigences du jury d'agrément du Titre RNCP de Psychologue du Travail :

> *« Une direction générale contacte un psychologue du travail et formule la demande suivante : "Nous constatons une multiplication inhabituelle des arrêts maladie au sein d'un service opérationnel. Nous souhaitons que vous mettiez en place d'urgence une cellule d'écoute téléphonique ou sur site." »*

A. Le diagnostic de la commande patronale : pourquoi l'employeur formule-t-il cela ?

L'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat (art. L. 4121-1 du Code du travail). Face à une dégradation visible, deux logiques coexistent :

- **La démarche sincère :** Une direction désemparée qui perçoit un dysfonctionnement sans parvenir à l'objectiver et recherche un tiers expert.

- **L'ouverture du parapluie juridique :** Mettre en place un dispositif d'écoute pour pouvoir prouver devant les tribunaux (prud'hommes, tribunal judiciaire) ou l'inspection du travail que « l'entreprise a tout mis en œuvre pour prendre soin de ses salariés », tout en externalisant la faute sur la fragilité psychologique individuelle des agents.

B. Le déplacement clinique de la demande : le refus du piège individuel

Pour le clinicien du travail, accepter la demande telle quelle équivaudrait à cautionner l'individualisation des risques psychosociaux. Le psychologue déplace méthodologiquement le regard :

- **Le secret médical absolu :** L'employeur n'a pas accès au motif médical de l'arrêt de travail. Le volet médical (volet 1) est strictement réservé au médecin-conseil de la CPAM. Même en cas de contrôle patronal (mandatement d'un médecin contrôleur), celui-ci vérifie uniquement la présence du salarié à son domicile et la validité administrative de l'arrêt, sans jamais divulguer la pathologie.
- **Interroger l'organisation :** Pourquoi ces arrêts surviennent-ils maintenant ? Quels ont été les changements technologiques récents, les restructurations, les mutations managériales, les départs non remplacés ?
- **Rétablir le travail prescrit vs le travail réel :** Les salariés disposent-ils des moyens matériels, humains et temporels d'accomplir leur tâche ? L'activité est-elle empêchée ?

3. Cartographie Épistémologique : PTO vs Cliniques du Travail du Cnam

Dr. Lutumba clarifie la ligne de partage théorique et méthodologique fondamentale au sein de la discipline :

Dimension	Psychologie du Travail et des Organisations (PTO)	Cliniques du Travail (Tradition Cnam)
Origines historiques	Psychotechnique d'après-guerre (adaptation de l'homme au poste, Taylor, Münsterberg 1913), Psychologie sociale (dynamique de groupe de Lewin, leadership, motivation) et Psychologie de la santé.	Psychopathologie du travail (Le Guillant, Sivadon, Veil, hôpital de Saint-Alban), Ergonomie francophone (Wisner), Psychodynamique (Dejours), Clinique de l'activité (Clot).
Démarche épistémologique	**Hypothético-déductive & Quantitative :** Modèles posés a priori, administration de questionnaires standardisés, analyses corrélationnelles et statistiques.	**Inductive & Qualitative :** Partir du terrain, de l'observation minutieuse de l'activité réelle et de la parole subjective des travailleurs.
Objet d'analyse	Les attitudes, la satisfaction, la motivation, l'engagement organisationnel, les traits de personnalité et l'adéquation au poste.	**Le travail réel :** Les conflits de critères, l'arbitrage subjectif, les défenses collectives, les règles de métier et les empêchements.
Conception de la santé	Absence de détresse psychologique, scores faibles de stress ou d'anxiété sur des échelles normées (ex: Karasek, Siegrist).	**Capacité normative et pouvoir d'agir :** La santé est le pouvoir d'agir sur son milieu, d'exprimer son style personnel et d'être reconnu par ses pairs.

Le Modèle de l'Activité selon Yves Clot (Module PST106)

Rappelé avec force en séance : le psychologue du travail décompose l'action en trois cercles concentriques :

1. **La Tâche (le travail prescrit) :** Ce que l'organisation demande formellement (objectifs, procédures, fiches de poste, cadences imposées).
2. **L'Activité réalisée :** Ce que l'opérateur met concrètement en œuvre dans le compromis opératoire pour faire face aux aléas et aux pannes.
3. **Le Réel de l'Activité (concept princeps d'Yves Clot) :** L'activité ne se réduit pas à ce qui est visible. Elle englobe tout le refoulé de l'action : *ce que l'on ne fait pas, ce que l'on voudrait faire mais que l'on n'a pas pu faire, ce que l'on est empêché de faire, et ce que l'on fait pour ne pas faire*. C'est dans cet écart que s'enracine la souffrance éthique et la fatigue psychique.

4. Les Grandes Écoles Cliniques & la Résonance Symbolique

Louis Le Guillant, Paul Sivadon & Claude Veil

Pères de la *Psychopathologie du travail* d'après-guerre. Expérience fondatrice de l'hôpital de Saint-Alban (1940-1950) : découverte que le travail n'est pas qu'une cause d'aliénation mais un puissant **médiateur thérapeutique et réparateur de la santé psychique** chez les patients psychotiques. Études célèbres sur la « névrose des téléphonistes » et les « bonnes à tout faire ».

Christophe Dejours (Psychodynamique du Travail)

Théorise la centralité du travail dans la construction de l'identité adulte. Le sujet continue de se forger à travers les épreuves du réel. Analyse la confrontation entre contraintes organisationnelles et pulsions subjectives, générant des **stratégies défensives individuelles et collectives** (virilisme, idéologies défensives de métier) pour conjurer l'angoisse.

Marc-Éric Bobillier-Chaumon (Clinique des Usages)

Enseignant au Cnam (PST124). Analyse l'impact des artefacts technologiques, des systèmes automatisés et désormais de l'**IA agentique et du scraping algorithmique**. Question fondamentale : comment préserver l'outil au service du geste de l'opérateur et conjurer le risque de métamorphoser l'humain en simple appendice ou variable d'ajustement logiciel ?

Eugène Enriquez & Vincent de Gaulejac

Piliers de la *Psychosociologie clinique*. Analyse transversale (« niveau méso ») articulant psychanalyse et sociologie critique : décortiquent l'imaginaire organisationnel, le culte de la performance, la violence symbolique des dispositifs d'évaluation managériale et la souffrance liée à la perte d'idéal.

Le Concept Fondateur de « Résonance Symbolique » (Christophe Dejours)

Dr. Lutumba s'arrête longuement sur la résonance symbolique, piège clinique majeur des entretiens individuels :

Définition clinique : Phénomène par lequel la *scène professionnelle actuelle* vient faire écho, réveiller ou réactiver des traumatismes, des blessures narcissiques ou des relations d'objet non résolues sur la *scène personnelle et familiale passée*.

Exemple clinique explicité par Dr. Lutumba : Une salariée s'effondre en larmes face aux exigences fermes de sa cheffe de service, vivant la situation comme une maltraitance destructrice (« elle me détruit, elle me persécute »). Au fil de l'entretien, il apparaît que cette manageuse réactive l'image d'une mère ou d'une sœur autoritaire et humiliante.

La posture rigoureuse du psychologue du travail :

- Accueillir la parole sans mépris ni déni : le clinicien comprend la résonance symbolique.
- **Rétablir l'altérité et le tiers-travail :** « Votre manageuse n'est ni votre mère, ni votre sœur. C'est une cadre d'entreprise investie d'une fonction d'organisation. Quel est son mandat ? De quoi avez-vous besoin pour travailler ? »
- **Borner son mandat :** Le psychologue du travail ne réalise pas une psychanalyse de l'histoire familiale. Si la personne souhaite élaborer sur son passé, il l'oriente vers un psychologue clinicien de ville en libéral ou en CMP.

5. De la Commande à la Demande & Les 3 Niveaux de Prévention

A. « Analyser la demande, c'est déjà une action de transformation »

Contrairement au technicien ou à l'ingénieur conseil qui réceptionne un cahier des charges et formule une offre fermée, l'intervention psychosociologique débute dès la première minute du recueil :

- **La Commande :** C'est le mandat contractuel formel (le devis, le bon de commande signé par la direction, la lettre de mission institutionnelle).
- **La Demande :** C'est l'expression subjective et latente d'une problématique non résolue par le système. Elle émane souvent de multiples acteurs aux intérêts divergents (Direction, CSE, salariés, médecin du travail).
- **La Maïeutique clinique :** En interrogeant le commanditaire (« Pourquoi maintenant ? Qui vous a alerté ? Qu'avez-vous déjà tenté ? Que craignez-vous ? »), le psychologue commence à décentrer les acteurs de leurs représentations individualisantes et prépare le terrain d'une intervention collective.

B. Les 3 Niveaux de Prévention : L'Exemple Princeps de l'EHPAD (Dr. Lutumba)

En complément des 9 principes généraux de prévention (Code du travail, art. L. 4121-2), le psychologue structure son action selon la triade de Caplan adaptée aux organisations de travail :

Niveau de Prévention	Définition & Logique d'Action	Illustration Clinique : L'EHPAD (2020 – 2024)
Prévention Primaire (Agir sur la cause à la conception)	Intervenir **en amont absolu**, dès la conception de l'organisation, des locaux, des outils ou des budgets, pour éliminer le risque à sa source.	**Ouverture de l'EHPAD en 2020 :** Les résidents sont valides. Mais la direction anticipe la dégradation inéluctable à 4 ans : installation immédiate de *rails lève-malade au plafond* dans toutes les chambres et budgétisation prévisionnelle de 2 postes d'aides-soignants supplémentaires pour 2024.
Prévention Secondaire (Former & amortir face aux signaux)	Le risque est présent et identifié. L'organisation met en place des mesures d'accompagnement, des formations et des règles d'alerte pour éviter l'aggravation.	**Situation en 2022 :** Les résidents perdent en autonomie, la fatigue et les micro-tensions apparaissent dans les équipes de nuit. Mise en place d'ateliers d'analyse des pratiques, formation à la manutention bientraitante et création d'une fiche d'alerte RH précoce.
Prévention Tertiaire (Réparer dans l'urgence la crise)	Le dommage est avéré : burn-outs massifs, accidents graves, arrêts en cascade, conflits ou violences. Intervention réparatrice en urgence.	**Crise aiguë en 2024 :** Aucune anticipation n'a été menée. Les équipes sont à bout de souffle, le sous-effectif est critique, les arrêts maladie explosent et un soignant à bout de nerfs en vient à séquestrer un collègue dans un cagibi. Le psychologue intervient en gestion de crise.

6. Typologie des Dispositifs d'Accompagnement & d'Étayage

A. Dispositifs Individuels

- **La Consultation Souffrance au Travail :** Théorisée par Marie Pezé (réseau Souffrance et Travail, dans le sillage de l'IPDT de Dejours). Ce n'est pas une psychothérapie : l'entretien décortique la tâche, les

relations managériales, les pathologies de surcharge (burn-out, usure) et réintègre l'histoire professionnelle.

- **Le Maintien dans l'Emploi & Retour après Maladie :** Développé notamment au sein des SPST (Services de Prévention et de Santé au Travail) et théorisé par Dominique Lhuilier. « Maintien dans l'emploi » ne signifie pas maintien au poste à tout prix : cela inclut la transition, la reconversion et la négociation d'un nouveau rapport au travail.

B. Dispositifs Collectifs : Matrice Comparative Indispensable

Dispositif	Composition & Participants	Présence Hiérarchique ?	Finalité & Modalités Cliniques
Régulation d'Équipe	Équipe de travail opérationnelle confrontée à un blocage ou un dysfonctionnement.	**Oui, possible et souvent nécessaire**, car la hiérarchie détient les leviers organisationnels de décision.	Dénouer un conflit interpersonnel ou fonctionnel en le ramenant impérativement sur le **tiers-travail** (règles de partage des tâches, flux d'information, arbitrages).
Analyse des Pratiques (APP)	Groupe homogène de **pairs de même métier** (ex: éducateurs, infirmières, psychologues).	**NON, FORMELLEMENT EXCLUE.** Aucun supérieur ni subordonné.	Élaboration sur le geste professionnel et l'éthique de métier. Les participants viennent s'exposer dans leur vulnérabilité ; un tiers garant extérieur anime la maïeutique.
Intervision	Collectif restreint de professionnels pairs (ex: 6 à 8 psychologues du travail).	**Non** (espace autogéré d'égaux).	Partage horizontal d'expériences cliniques et de dossiers complexes **sans superviseur attitré**. Apport mutuel de regards croisés.
Supervision	Un praticien individuel ou une équipe avec un **superviseur senior extérieur**.	**Non** (cadre d'étayage confidentiel externe).	Analyse approfondie de la posture clinique, du contre-transfert, des résonances personnelles, des blocages théorico-méthodologiques et de la déontologie.

7. Déontologie, Posture Clinique & Règles d'Or de Restitution

A. Statut Légal et Indépendance du Psychologue

Dr. Lutumba insiste sur les repères juridiques indispensables pour soutenir sa posture devant les directions :

- **Loi du 25 juillet 1985 (art. 44) & N° RPPS :** Le psychologue du travail est un professionnel de la santé mentale et des sciences humaines. Il dispose d'un titre protégé. Il n'est pas un auxiliaire médical ni un professionnel paramédical sous tutelle. **Aucun médecin ni chef d'entreprise ne peut lui prescrire son protocole, ses outils ou le nombre de ses séances.**
- **Le Code de déontologie des psychologues (refontes 2012, 2021-2022) :** Le principe 1er stipule que *le respect de la personne dans sa dimension psychique et physique est un droit inaliénable*. Dr. Lutumba conseille d'annexer systématiquement le Code aux propositions d'intervention.
- **Le consentement libre et éclairé :** La participation des salariés est strictement volontaire. Si un agent est convoqué par son manager pour « aller voir le psychologue », le clinicien commence par reformuler le cadre : le salarié a le droit absolu de ne rien dire ou de mettre fin immédiatement à l'entretien.

B. Les 3 Règles d'Or pour la Rédaction des Rapports et la Restitution

🚫 **RÈGLE D'OR N°1 : BANNIR FORMELLEMENT TOUT VERBATIM INDIVIDUEL**

En milieu de travail, **ne jamais insérer de citations directes ou de verbatims individuels dans un rapport institutionnel**, même présentés comme « anonymes » ! Les collègues et les supérieurs reconnaissent immédiatement les tics de langage, le vocabulaire singulier, le style ou les revendications d'une personne précise. Cela expose immanquablement le salarié à des sanctions déguisées, à la mise au placard ou au harcèlement de ses pairs. La restitution doit toujours synthétiser des *processus organisationnels collectifs* et rester strictement factuelle.

⚖️ **RÈGLE D'OR N°2 : LE PIÈGE JURIDIQUE DE LA NOTION DE « HARCÈLEMENT MORAL »**

Le clinicien accueille la souffrance de celui qui dit « je suis harcelé », mais fait preuve d'une pédagogie rigoureuse : **le harcèlement moral est une qualification juridique pénale et prud'homale dont l'appréciation relève du seul juge.**

Rappel d'actualité déontologique : Les médecins traitants qui mentionnent « arrêt pour harcèlement moral au travail » sont régulièrement condamnés par les chambres disciplinaires de l'Ordre des Médecins à la demande des employeurs, pour immixtion et établissement d'attestation de faits non constatés par eux-mêmes en entreprise. Le psychologue requalifie la situation en termes de dégradation des conditions de travail, d'isolement ou de conflits de critères.

RÈGLE D'OR N°3 : L'IMPÉRATIF CLINIQUE DU TRAVAIL EN BINÔME

Dr. Lutumba souligne qu'elle n'intervient presque jamais seule en entreprise, y compris dans son activité libérale. **Intervenir à deux (deux psychologues du travail ou un binôme psychologue/ergonome)** constitue le meilleur rempart contre les pressions institutionnelles, l'isolement affectif, le risque de séduction ou de capture par le management, et garantit un espace permanent de co-élaboration réflexive.

C. Concepts Transversaux Complémentaires

- **Le Travail Émotionnel (Arlie R. Hochschild, 1983) :** L'effort psychique coûteux imposé aux salariés de service ou d'accueil consistant à façonner, réprimer ou feindre des émotions prescrites par l'organisation (le sourire obligatoire face à des usagers agressifs). Intégré comme axe majeur du rapport Gollac (2011) sur les RPS.
- **L'Éthique du Care (Pascale Molinier) :** L'invisibilisation du travail de soin, de sollicitude et de maintien du lien dans les métiers du médico-social et des services.
- **Le refus de la Déflexion externe :** Tendance managériale systématique à dévier l'explication des troubles vers la vie privée (« il divorçait », « il était fragile »). Le psychologue réinternalise le travail : comment l'organisation a-t-elle fragilisé le salarié au point que son équilibre vacille ? Marie Pezé a forgé la notion de *« suicide blanc »* pour désigner les tentatives ou signaux masqués qui précèdent l'irréversible.

8. Conseils de Notation & Repères pour l'Examen

📝 **STRUCTURATION DES RÉPONSES POUR L'ÉPREUVE ÉCRITE (OPTIONS A ET B)**

- **Option A (Dissertation) :** Si le sujet porte sur l'accompagnement ou l'intervention, problématiser impérativement la formule canonique : *« En quoi analyser la demande en milieu professionnel constitue-t-il déjà un acte politique et clinique de transformation ? »*. Articuler avec le statut déontologique et les 3 niveaux de prévention.
- **Option B (Étude de Cas) :** Si une direction demande une « cellule d'écoute », démarrer impérativement en posant le cadre du secret médical, reformuler la demande collectivement, proposer des espaces de délibération sur le travail réel (et non une psychothérapie de couloir) et expliciter le rendu des conclusions sans verbatims.